Guía para la presentación de Ateneos Clínicos

Dirigido a: Médicos internos

Objetivo del documento: Establecer lineamientos claros y estandarizados para la elaboración, presentación y análisis de casos clínicos, promoviendo el razonamiento clínico, la apropiación del conocimiento y el desarrollo de habilidades académicas y comunicativas.

Conceptos:

Ateneo Clínico: Actividad académica de carácter periódico, orientada al análisis crítico de casos clínicos reales, que integra la experiencia asistencial con la evidencia científica, promoviendo el razonamiento clínico, la toma de decisiones y el aprendizaje colaborativo. El término ateneo proviene del latín *Athenaeum* y del griego *Athḗnaion*, que hacía referencia a los lugares dedicados al estudio, la enseñanza y el debate, asociados a Atenea, diosa de la sabiduría. *(WFME. Global Standards for Medical Education; Harden RM, Laidlaw JM. Essential Skills for a Medical Teacher. Elsevier)*

1. Consideraciones generales

- La presentación del caso clínico es una **actividad académica obligatoria**.
- Debe realizarse de manera ordenada, clara, diligente y basada en evidencia.
- Es obligatorio el uso de la plantilla institucional vigente para la presentación.
- El expositor debe demostrar conocimiento del caso, apropiación del tema y capacidad de análisis crítico.

2. Estructura del caso clínico

La presentación debe seguir estrictamente el siguiente orden:

2.1 Presentación del caso

- Servicio
- Fecha de atención
- Edad y sexo del paciente
- Motivo de consulta

(No incluir datos que permitan la identificación específica del paciente)

- Enfermedad actual (cronológica y clara): NO transcribirlo de la historia clínica.
- Antecedentes
- Revisión por sistemas (enfocada al caso)
- Examen físico: signos vitales, hallazgos positivos y negativos relevantes
- Enfoque sindromático

- Paraclínicos relevantes
- Imágenes diagnósticas (si aplica)
- Interpretación clínica de los resultados

- Diagnóstico principal
- Diagnósticos diferenciales

- Justificación clínica
- Conducta diagnóstica y terapéutica realizada.

4. Análisis del caso

- Análisis crítico del proceso diagnóstico.
- Relación entre clínica, paraclínicos y evolución.
- Justificación de decisiones tomadas.
- Aprendizajes clave derivados del caso.

Este apartado es **fundamental** para la evaluación académica.

5. Revisión del tema

- Relacionada directamente con el diagnóstico principal.
- Basada en **literatura científica actualizada – últimos 5 años** (guías, estudios analíticos).
- Debe responder a:
    - Definición y fisiopatología (breve).
    - Criterios diagnósticos.
    - Manejo actual recomendado
    - Puntos clave para la práctica clínica.

6. Programación, lugar y tiempo de la actividad

6.1 Programación y lugar

- La actividad se realizará el último viernes de cada mes.
- Lugar: Sala de juntas de la UCI.
- La asistencia presencial es obligatoria para todos los médicos internos.
- La presentación se hará modalidad mixta: presencial y virtual.

6.2 Selección del caso clínico

- Cada interno podrá escoger un caso clínico de su interés, correspondiente a cualquiera de las rotaciones realizadas.
- El interno deberá solicitar apoyo académico a un especialista relacionado con el caso clínico.

- En caso de que el especialista seleccionado no sea el coordinador del área, se deberá gestionar una invitación formal para su participación en el momento de la presentación del caso clínico.

6.3 Tiempo de la actividad

- **Total: 60 minutos,** dividido de la siguiente forma:
- **30 minutos máximo:** Presentación del caso clínico y revisión del tema.
- **30 minutos:**
  - Preguntas por parte del personal docente y especialistas
  - Discusión académica.
  - Resolución de dudas.
  - Retroalimentación.

7. Criterios de evaluación

La calificación tendrá en cuenta:

- Uso adecuado de la plantilla institucional.
- Claridad, orden y coherencia de la presentación.
- Dominio del caso clínico.
- Capacidad de análisis y razonamiento clínico.
- Calidad de la revisión del tema (bibliografía)
- Forma de explicación (lenguaje médico adecuado, claridad, seguridad).
- Manejo del tiempo.
- Respuesta a preguntas y participación en la discusión.

8. Recomendaciones finales

- Preparar el caso con suficiente antelación.
- Evitar lectura textual de diapositivas.
- Diapositivas claras, con contenido conciso y sin exceso de texto.
- Utilizar lenguaje médico claro y preciso.
- Enviar con ocho (8) días de antelación documento breve resumen del caso a Líder de Academia e Investigación.
- Se debe entregar documento final con el caso y aspectos clave de la revisión.